Curso de Medicina
Internato 2026.1.1
Avaliação Modular: Clínica Médica

Questões:

1) Considerando os princípios de saúde pública e a eficiência do sistema de emergência, qual das seguintes estratégias seria a mais eficaz para reduzir o tempo entre o início dos sintomas de AVC e o atendimento médico adequado?
a) Promover campanhas de conscientização com foco em identificar os fatores de risco, como hipertensão e diabetes, recomendando consultas médicas anuais.
b) Realizar campanhas educativas massivas sobre a mnemônica FAST, enfatizando a importância de ligar imediatamente para os serviços de emergência (192) ao detectar sinais de AVC.
c) Implementar programas para aumentar o número de ambulâncias e reduzir o tempo de resposta dos serviços de emergência.
d) Treinar os profissionais da saúde em unidades de pronto atendimento para reconhecer precocemente sinais de AVC e realizar exames de imagem avançados mais rapidamente.
Gabarito:Alternativa B
Justificativa: A educação da população sobre o reconhecimento imediato dos sinais de AVC, por meio de campanhas de conscientização baseadas na mnemônica FAST, e a orientação para ligar para os serviços de emergência são as medidas mais eficazes para reduzir o tempo de chegada ao hospital, que é o fator crucial na administração de tratamentos que salvam vidas, como trombólise ou trombectomia.

2) Sobre protocolos de imagem e diagnóstico com o uso de Tomografia Computadorizada (TC) no AVC, assinale a afirmativa correta.
a) Auxilia a determinar a elegibilidade do paciente à trombectomia mecânica (TM).
b) A recomendação é de que a TC seja realizada nos primeiros 45 minutos após a chegada do paciente.
c) A TC ainda não é capaz de diferenciar AVC isquêmico de AVC hemorrágico.
d) A TC sem contraste continua sendo a modalidade de imagem de primeira linha na maioria dos atendimentos de emergência.
Gabarito: Alternativa D
Justificativa: A TC sem contraste continua sendo a modalidade de imagem de primeira linha na maioria dos atendimentos de emergência, devido à sua disponibilidade e capacidade de diferenciar rapidamente o AVCi do AVC hemorrágico. A recomendação é de que a TC seja realizada dentro dos primeiros 25 minutos após a chegada do paciente, para determinar a elegibilidade para o tratamento com trombólise IV com rt-PA.
A TC sem contraste é a imagem de escolha inicial na maioria dos serviços de emergência porque:
Está amplamente disponível. É rápida e eficaz para excluir hemorragia intracraniana, o que é fundamental antes de iniciar trombólise. Embora não detecte o AVC isquêmico nas primeiras horas em muitos casos, é suficiente para decisões terapêuticas imediatas, como trombólise intravenosa.
Justificativa das alternativas incorretas:
a) Auxilia a determinar a elegibilidade do paciente à TM. – Incompleta e imprecisa.
A TC sem contraste isoladamente não é suficiente para definir a elegibilidade para trombectomia mecânica (TM). Para isso, é necessário um protocolo de imagem mais avançado: angioTC e TC de perfusão, que identificam oclusão de grandes vasos e penumbra isquêmica.
b) A recomendação é de que a TC seja realizada nos primeiros 45 minutos após a chegada do paciente. - Incorreta. O ideal é que a TC sem contraste seja feita nos primeiros 20 a 25 minutos, e o laudo esteja disponível até os 45 minutos, conforme as diretrizes da AHA/ASA e protocolos como “door-to-needle”.
c) A TC ainda não é capaz de diferenciar AVCi de AVC hemorrágico. – incorreta.
A principal função da TC sem contraste é justamente diferenciar AVC isquêmico (AVCi) de hemorrágico (AVCh) nas primeiras horas. Ela detecta sangramento intracraniano agudo com alta sensibilidade.

3) G.B.A, 52 anos, hipertensa, obesa, tabagista, em pós-operatório de artrodese de joelho esquerdo há 20 dias, procurou atendimento médico devido ao quadro de dispneia súbita, sem outros sintomas

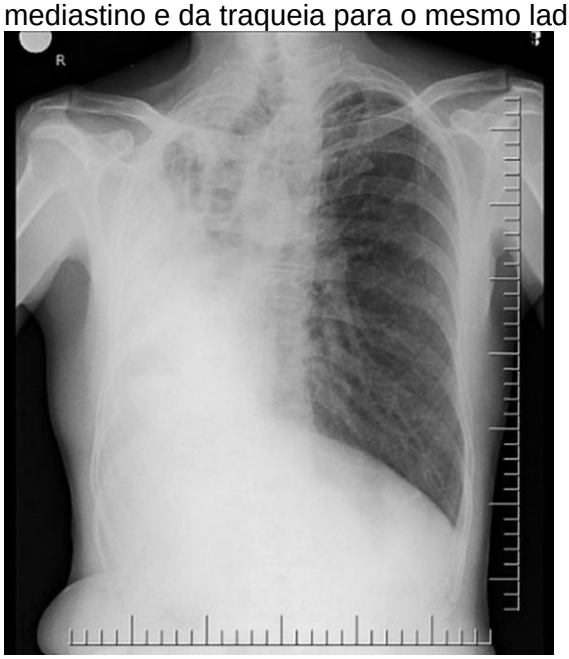
associados. Ao exame físico paciente estava acordada, lúcida e orientada, Glasgow 15/15, referindo dispneia ao repouso. Mucosas hidratadas, anictérica, acianótica, afebril.
Sinais vitais: 140 x 90 mmHg FC: 113 bpm FR: 26 irpm SatO2: 95%.
Exame físico sem alterações.
Sobre a conduta do quadro clínico acima, o que podemos afirmar:
a) Para elucidação diagnóstica os primeiros exames diagnosticados seriam: radiografia de tórax, eletrocardiograma, gasometria arterial e cintilografia pulmonar.
b) Devido a principal hipótese diagnóstica ser DPOC exacerbado, os principais exames a serem solicitados seriam tomografia de tórax sem contraste e espirometria.
c) A hipótese de tromboembolismo pulmonar de acordo com o escore de Wells, é de alta probabilidade e o primeiro exame solicitado seria a angiotomografia de tórax.
d) Para elucidação diagnóstica os primeiros exames solicitados seriam: radiografia de tórax, eletrocardiograma, gasometria arterial e d-dímero.
Gabarito: Alternativa D.
Justificativa: Paciente com quadro de dispneia súbita, taquicardia e taquipneia, em pós operatório recente, a hipótese diagnóstica mais plausível seria tromboembolismo pulmonar com estabilidade hemodinâmica, de acordo com os critérios de wells paciente tem moderada probalidade para TEP, e então além dos exames básicos como radiogragia de tórax, eletrocardiograma e gasometria arterial, o exame solicitado seria o d-dímero e se ele vier alterado, o exame de seguimento seria a angiotomografia de tórax.

4) T.E.M., mulher de 60 anos, portadora de lúpus eritematoso sistêmico (LES), internada há 6 dias na enfermaria de clínica Médica para investigação de dor torácica inespecífica, febre e derrame pleural bilateral. Nas últimas 12 horas, passou a apresentar dispneia progressiva, ortopneia e fadiga aos mínimos esforços. Enfermagem relata que a paciente está mais confusa e muito hipotensa hoje.
Exame físico: PA: 85 x 55 mmHg FC: 118 bpm FR: 28 irpm SpO_2 : 92% em O_2 nasal
Turgência jugular aumentada; Ictus cordis impalpável; Bulhas cardíacas hipofonéticas; MV presente bilateralmente, sem estertores; Abdome: normal; MMII: sem edema
Tempo de enchimento capilar: > 3 segundos. Sem sinais flogísticos locais
ECG: baixa voltagem difusa e alternância elétrica.
Raio-X de tórax: aumento da área cardíaca, sem congestão pulmonar.
Eco à beira-leito (POCUS): derrame pericárdico volumoso com colapso diastólico do VD.
Qual a conduta mais imediata e adequada neste caso?
a) Iniciar dobutamina e manter observação com monitoramento invasivo.
b) Administrar furosemida IV e solicitar TC de tórax com contraste.
c) Solicitar avaliação da UTI e iniciar prednisona EV 1 mg/kg/dia.
d) Realizar pericardiocentese guiada por ecocardiografia à beira-leito.

Gabarito: Alternativa D.
Justificativa: O quadro é clássico de tamponamento cardíaco:
Hipotensão, Turgência jugular, Bulhas abafadas (tríade de Beck) Sinais de baixo débito (TEC aumentado, confusão) ECG com baixa voltagem e alternância elétrica
Eco com colapso diastólico do VD e derrame importante
Conduta definitiva e urgente: drenagem do espaço pericárdico para alívio da pressão externa sobre o coração, que está impedindo o enchimento diastólico adequado (→ baixo débito e choque).
Justificativas das alternativas incorretas:
a) Iniciar dobutamina e manter observação com monitoramento invasivo. – Errada: Inotrópico pode temporizar a situação, mas não trata a causa mecânica. O paciente pode evoluir rapidamente para PCR.
b) Administrar furosemida IV e solicitar TC de tórax com contraste. – Errada: Furosemida piora a pré-carga e pode precipitar colapso circulatório. TC é desnecessária e demorada em um cenário de emergência clínica.
c) Solicitar avaliação da UTI e iniciar prednisona EV – Errada: Embora o quadro possa ser associado ao LES, corticóide não é a prioridade, e UTI sem intervenção imediata não resolve o choque obstrutivo. O tempo aqui é crítico.
Dica prática:
Tamponamento cardíaco = emergência clínica com choque obstrutivo.
Diagnóstico clínico + ecocardiografia à beira-leito → indicam drenagem imediata do pericárdio.

5) M.S.L., 70 anos, masculino, ex-tabagista (40 maços/ano), com diagnóstico conhecido de DPOC GOLD III (moderado/grave), em uso domiciliar de tiotrópio e salbutamol spray. Foi internado há 2 dias na enfermaria de clínica médica por pneumonia em base direita, em tratamento com ceftriaxona e azitromicina. Hoje, evolui com piora da dispneia, aumento da frequência respiratória, sibilância difusa e confusão mental leve.
Exame físico: PA: 118 x 76 mmHg FC: 112 bpm FR: 30 irpm Temp: 37,2°C SpO_2 : 88% em O_2 por cateter nasal 2L/min. MV globalmente diminuído, sibilos difusos, sem estertores.
Gasometria arterial em O_2 a 2 L/min: pH: 7,31 pCO_2 : 58 mmHg HCO_3^-: 27 mEq/L BE: +2 $SatO_2$: 89%
Qual a conduta mais adequada neste momento?
a) Iniciar ventilação mecânica invasiva e antibiótico de amplo espectro com Meropenem.
b) Realizar VNI (ventilação não invasiva), ajustar oxigenoterapia e iniciar corticoide sistêmico.
c) Aumentar o fluxo de O_2 para 10 L/min e repetir a gasometria em 2h.
d) Suspender antibiótico e iniciar heparina plena por suspeita de TEP.
Gabarito: Alternativa B.
Justificativa: Este é um quadro clássico de exacerbação de DPOC com retenção de CO_2 (hipercapnia), acidose leve e dessaturação. A abordagem imediata deve incluir:
Ventilação não invasiva (VNI) → melhora troca gasosa, reduz trabalho respiratório e pode evitar intubação.
Ajuste da oxigenoterapia → cuidado para não exacerbar hipercapnia; manter $SatO_2$ entre 88–92%.
Corticosteroide sistêmico (prednisona 40 mg/dia ou hidrocortisona EV) → reduz inflamação brônquica e acelera a recuperação.
Broncodilatadores de ação curta (salbutamol/ipratrópio nebulizados).
Justificativas das alternativas incorretas:
a) VM invasiva e Meropenem. – Errada: Invasão precoce da via aérea deve ser evitada se possível. O paciente ainda tem parâmetros para tentativa com VNI. Meropenem é desnecessário nesse momento (não há sinais de sepse grave ou falha antimicrobiana).
c) Oxigênio a 10 L/min. – Errada: O uso de O_2 em fluxo alto pode exacerbar retenção de CO_2 em pacientes com drive respiratório dependente de hipóxia (risco de rebaixamento e acidose respiratória grave).
d) Suspender antibiótico e iniciar heparina plena. – Errada: Embora o TEP possa cursar com dessaturação e dispneia, não há sinais clínicos suficientes para fazer esse diagnóstico sem investigação. Além disso, o paciente tem pneumonia recente, e a interrupção do antibiótico seria um erro.

6) Paciente de 55 anos, com histórico de neoplasia brônquica, realiza radiografia de tórax que mostra redução difusa da transparência do hemitórax direito com retração de estruturas, desvio do mediastino e da traqueia para o mesmo lado. Qual a principal hipótese diagnóstica?



a) Derrame pleural maciço
b) Atelectasia do pulmão direito
c) Pneumotórax hipertensivo
d) Consolidação lobar

Resposta: letra B
Justificativa: O colapso pulmonar leva à perda de volume, causando desvio mediastinal ipsilateral, ao contrário do derrame ou pneumotórax hipertensivo que desviam para o lado oposto.
Título da aula: Lesões hipotransparentes.
Competências: Diferenciar atelectasia de outras opacidades pela análise do desvio de estruturas.

7) Homem de 58 anos, hipertenso irregular, chega à emergência com instalação súbita de hemiparesia direita e disartria há cerca de 30 minutos. Na admissão, apresenta PA de 230 × 120 mmHg, sem uso de anticoagulantes. É realizada tomografia computadorizada de crânio sem contraste, que evidencia imagem hiperdensa, bem delimitada, medindo aproximadamente 2,5 cm, localizada na região nucleocapsular esquerda, envolvendo putâmen e cápsula interna.



Com base nos achados e no contexto clínico, qual é o diagnóstico mais provável?
a) Hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva nucleocapsular.
b) Hemorragia subaracnóide secundária à ruptura aneurismática.
c) Hematoma intraparenquimatoso lobar por angiopatia amiloide.
d) Infarto isquêmico hiperagudo com sinal da artéria hiperdensa.
Resposta: letra A
Justificativa: A hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva é causada por ruptura de microaneurismas de Charcot–Bouchard, especialmente nos vasos lenticuloestriados, que irrigam putâmen, globo pálido e cápsula interna — região nucleocapsular. Trata-se do local mais comum de sangramento hipertensivo.
Título da Aula: Avaliação por Imagem do Acidente Vascular Encefálico.

8) Um homem de 45 anos, tabagista e etilista crônico, procura atendimento médico devido a tosse seca, dor torácica pleurítica e dispneia progressiva há três semanas. Relata febre vespertina, sudorese noturna e perda ponderal de 5 kg no último mês. O exame físico evidencia diminuição do frêmito toracovocal e macicez à percussão no hemitórax direito. A radiografia de tórax confirma um derrame pleural moderado à direita. A toracocentese revela um líquido pleural exsudativo, linfocítico, com ADA (adenosina deaminase) de 75 U/L (Normal: 30 a 40 U/L) e cultura negativa para Mycobacterium tuberculosis.
Diante desse quadro, qual o próximo passo mais adequado para o diagnóstico?

a) Repetir a toracocentese para nova análise microbiológica do líquido pleural
b) Iniciar empiricamente esquema RIPE (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol), pois o diagnóstico já pode ser considerado
c) Realizar biópsia pleural fechada para análise histopatológica e pesquisa de BAAR
d) Solicitar teste tuberculínico (PPD) e interferon-gamma (IGRA)para confirmar a infeção tuberculosa

 Gabarito: c) realizar biópsia pleural fechada para análise histopatológica e pesquisa de BAAR

 Raciocínio clínico
O quadro é altamente sugestivo de **derrame pleural tuberculoso**:
- Sintomas constitucionais: febre vespertina, sudorese noturna, perda de peso
- Derrame pleural unilateral
- Líquido **exsudativo linfocítico**
- **ADA elevado (75 U/L)** → fortemente sugestivo de TB pleural
 Porém:
- Cultura negativa NÃO exclui tuberculose (baixa sensibilidade no líquido pleural)
 Portanto, é necessário **confirmação diagnóstica**.

 Por que a letra C está correta?
A **biópsia pleural fechada**:
- Aumenta muito a sensibilidade diagnóstica
- Permite:
  - Histopatologia → granulomas
  - Pesquisa de BAAR
  - Cultura
 É o **próximo passo clássico** após toracocentese sugestiva mas não confirmatória.
❌Análise das alternativas erradas
a) Repetir toracocentese ❌
- Baixa sensibilidade microbiológica
- Repetição raramente muda o diagnóstico
- Não é o próximo passo recomendado
b) Iniciar RIPE empiricamente ❌
- Pode ser feito em alguns cenários, MAS:
- Em prova e prática ideal → **confirmar diagnóstico primeiro**
- Especialmente em paciente estável
d) PPD e IGRA ❌
- Não diferenciam:
  - Infecção latente vs doença ativa
- Baixa utilidade em derrame pleural já sugestivo

9) Homem de 45 anos, etilista desde os 17 anos, tabagista, com queixas de dor epigástrica recorrente irradiada para o dorso, perda de peso progressiva e esteatorreia. Já foi submetido a múltiplas avaliações ambulatoriais, incluindo ultrassonografia abdominal e exames laboratoriais sem alterações significativas. Considerando o quadro clínico e a suspeita diagnóstica, qual alternativa apresenta corretamente o principal fator de risco, o exame complementar inicial mais indicado e o tratamento sintomático de escolha?
a) Hipercalcemia como fator predisponente; elastase fecal como exame de escolha; tratamento com antidepressivos tricíclicos
b) Tabagismo como fator causal primário; tomografia abdominal como exame inicial; conduta com restrição dietética exclusiva
c) Pancreatite auto-imune como hipótese principal; dosagem de igg4 como prioridade diagnóstica; tratamento com corticosteróides
d) Etilismo crônico como principal fator etiológico; tomografia abdominal como exame inicial útil; uso de enzimas pancreáticas para melhora da função exócrina
Gabarito: d) etilismo crônico como principal fator etiológico; tomografia abdominal como exame inicial útil; uso de enzimas pancreáticas
Raciocínio clínico
Quadro típico de **pancreatite crônica**:
- Dor epigástrica irradiada para dorso
- Etilismo crônico
- Perda de peso
- **Esteatorreia → insuficiência pancreática exócrina**

Por que a letra D está correta?
 Fator etiológico principal:
- Álcool (principal causa no adulto)
 Exame inicial:
- **Tomografia abdominal**
  - Detecta:

- Calcificações
- Atrofia pancreática
- Dilatação ductal

 Tratamento sintomático:

- **Reposição de enzimas pancreáticas**
  - Melhora digestão
  - Reduz esteatorreia
  - Pode aliviar dor

❌**Análise das alternativas erradas**

a) Hipercalcemia + elastase fecal + antidepressivo ❌

- Hipercalcemia é causa rara
- Elastase fecal é útil, mas não exame inicial principal
- Antidepressivos NÃO são tratamento padrão principal

b) Tabagismo como fator principal ❌

- Tabagismo é fator de risco, mas NÃO o principal (álcool é)
- Restrição dietética isolada é insuficiente

c) Pancreatite autoimune ❌

- Geralmente:
  - Icterícia
  - Massa pancreática
  - IgG4 elevado
- Não cursa classicamente com esteatorreia crônica típica do caso

10) Paciente do sexo feminino, 72 anos, diabética e tabagista, é admitida na emergência com hemiparesia à esquerda e fala arrastada, iniciadas há cerca de 2 horas. A tomografia computadorizada de crânio sem contraste foi solicitada. Considerando o diagnóstico de acidente vascular encefálico isquêmico, qual dos seguintes achados de imagem apareceria mais precocemente?



a) Hipodensidade difusa em todo o hemisfério esquerdo.
b) Desvio da linha média para direita.
c) Hiperdensidade da artéria cerebral média direita.
d) Encefalomalácia frontoparietal esquerda.

Resposta: letra C

Justificativa: A hiperdensidade da artéria cerebral média (sinal da artéria cerebral média hiperdensa) contralateral à hemiparesia é o achado mais precoce que indica a presença de trombo intra-arterial.

Título da Aula: Avaliação por Imagem do Acidente Vascular Encefálico.

Competências trabalhadas: Reconhecer padrões tomográficos da hemorragia hipertensiva. Correlacionar localização típica (nucleocapsular) com fisiopatologia (microaneurismas). Identificar achados diferenciais entre HSA, sangramento lobar e AVC isquêmico hiperagudo. Integrar dados clínicos (crise hipertensiva) e radiológicos para diagnóstico rápido.

11) Um homem de 67 anos foi internado há 8 dias por quadro de pielonefrite complicada. Iniciou tratamento empírico com ceftriaxona. Evoluiu inicialmente com melhora parcial, porém no 7º dia de internação voltou a apresentar febre, queda do nível de consciência e PCR em elevação. A urocultura inicial havia isolado Enterobacter cloacae sensível a ceftriaxona. Uma nova urocultura agora mostra crescimento do mesmo microrganismo, porém com o seguinte antibiograma:
· Resistência: ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima, ampicilina
· Sensibilidade: cefepime, piperacilina-tazobactam, carbapenêmicos
Qual é a explicação mais provável para essa mudança no perfil de sensibilidade?
a) Produção de ESBL induzida pela ceftriaxona.
b) Seleção de cepa com hiperprodução de AmpC induzida por ceftriaxona.
c) Mutações na PBP (penicillin-binding protein) pela pressão seletiva.
d) Falha terapêutica por biofilme.
Resposta: Letra B
Justificativa: Enterobacter cloacae, assim como Citrobacter freundii, Serratia marcescens, Providência, Morganella e Hafnia, possui a capacidade de produzir β-lactamase AmpC cromossômica, que pode ser: induzida pelo uso de cefalosporinas de 3ª geração (como a ceftriaxona),;hiperexpressa após alguns dias de terapia; resultando em resistência adquirida durante o tratamento. O padrão clássico de AmpC induzida é:
· resistência nova a ceftriaxona/cefotaxima/ceftazidima
· manutenção da sensibilidade ao cefepime (estável contra AmpC)
· sensibilidade mantida a carbapenêmicos

12) Homem, 38 anos de idade, há 5 dias apresenta dor epigástrica com irradiação para dorso, associada a náuseas e vômitos. Relata que a dor piora após a alimentação, reduzindo a ingestão alimentar. É etilista há 20 anos e relata libação alcoólica importante há 1 semana. Nega comorbidades e medicações de uso contínuo. Ao exame físico: PA: 140 x 85 mmHg, FC: 125 bpm, FR: 24 irpm e temperatura axilar de 37,8 °C. O abdome encontra-se distendido, com ruídos hidroaéreos reduzidos, doloroso à palpação epigástrica. O restante do exame físico está normal. O achado laboratorial que auxiliará na confirmação da hipótese diagnóstica é:
a) fosfatase alcalina pelo menos duas vezes acima do limite superior da normalidade
b) elevação de bilirrubina total e de bilirrubina direta com bilirrubina indireta normal
c) lipase pelo menos três acima do limite superior da normalidade
d) transaminases acima de 1000 U/L

c) lipase pelo menos três vezes acima do limite superior da normalidade
 Raciocínio clínico
O quadro é clássico de **pancreatite aguda (provavelmente alcoólica)**:
- Dor epigástrica irradiada para dorso
- Náuseas e vômitos
- Piora após alimentação
- História de etilismo + ingesta recente
- Taquicardia, distensão abdominal e íleo paralítico (RHA reduzidos)

 Por que a alternativa C está correta?
A **lipase sérica ≥ 3x o limite superior da normalidade**:
- É o **marcador laboratorial mais sensível e específico**
- Permanece elevada por mais tempo que a amilase
- Critério diagnóstico formal de pancreatite aguda

 Segundo diretrizes como o American College of Gastroenterology, o diagnóstico é feito com 2 de 3:
1. Dor típica
2. Lipase (ou amilase) ≥ 3x
3. Imagem compatível

❌Análise das alternativas erradas
a) Fosfatase alcalina elevada ❌
- Sugere **colestase/obstrução biliar**
- Pode aparecer em pancreatite biliar, mas **não confirma pancreatite**

b) Bilirrubina total e direta elevadas ❌
- Indica **colestase ou obstrução de via biliar**

- Pode ocorrer em pancreatite biliar, mas não é critério diagnóstico

d) Transaminases > 1000 U/L ✗

- Sugere mais fortemente:
  - **hepatite aguda viral**
  - lesão hepática isquêmica ou tóxica
- Não é padrão de pancreatite

13) Uma mulher de 68 anos, tabagista de 35 maços-ano, apresenta diagnóstico recente de DPOC. Refere dispneia aos moderados esforços (mMRC = 2) e nunca teve exacerbações prévias. A espirometria mostra VEF1 = 62% do previsto. Qual deve ser o tratamento inicial ideal para essa paciente?

a) Salbutamol conforme necessidade
b) Tiotrópio ou Fenoterol isolado
c) Glicopirrônio + Indacaterol
d) Formoterol + Budesonida

Resposta: Letra C

Justificativa: A paciente é Grupo B pelo GOLD (mMRC ≥ 2 e 0 exacerbações). O tratamento inicial recomendado para este grupo é LABA (indacaterol) + LAMA (Glicopirrônio) devido à superior eficácia sintomática.

14) Uma mulher de 72 anos, previamente independente, evolui nos últimos seis meses com lentidão para realizar atividades diárias, rigidez muscular e tremor fino de mãos ao repouso. Os sintomas são simétricos desde o início. Ela faz uso regular de flunarizina 10 mg/dia, Losartana 100mg/dia e Omeprazol 20 mg/dia. Nega uso de antipsicóticos, não consome álcool ou drogas ilícitas e não possui história familiar de doença de Parkinson. O exame neurológico confirma bradicinesia, rigidez plástica bilateral e tremor de repouso discreto. Qual é o diagnóstico mais provável e a conduta adequada?

a) Doença de Parkinson idiopática — iniciar levodopa/carbidopa.
b) Parkinsonismo iatrogênico — suspender flunarizina e acompanhar melhora clínica.
c) Parkinsonismo vascular — solicitar ressonância magnética de crânio.
d) Doença de Parkinson avançada — iniciar agonista dopaminérgico.

Resposta: Letra B

Justificativa: A paciente apresenta: uso prolongado de flunarizina, um dos fármacos que mais frequentemente causam parkinsonismo induzido por drogas, especialmente em idosos; bradicinesia, rigidez e tremor simétricos, característica típica de parkinsonismo farmacológico (diferente da apresentação assimétrica do Parkinson idiopático); evolução subaguda (meses), compatível com efeito acumulativo dopaminérgico da flunarizina; ausência de sinais autonômicos proeminentes e de sintomas pré-motores clássicos de Parkinson idiopático. A conduta correta é suspender a flunarizina e acompanhar. A melhora costuma ocorrer em semanas a meses.

15) Uma mulher de 72 anos apresenta perda progressiva de memória há 2 anos, inicialmente para fatos recentes. Nos últimos meses, familiares referem episódios de alucinações visuais bem formadas e flutuações acentuadas do estado de alerta, alternando períodos de lucidez com momentos de confusão. O exame neurológico revela rigidez muscular leve e bradicinesia. A ressonância magnética mostra atrofia cortical leve, sem achados focais. Qual é o diagnóstico mais provável?

a) Doença de Alzheimer
b) Demência vascular
c) Demência frontotemporal
d) Demência por corpos de Lewy

Resposta: Letra D

Justificativa: A tríade clássica da demência por corpos de Lewy está presente: Alucinações visuais vívidas, Flutuação cognitiva, Parkinsonismo (rigidez e bradicinesia). Alzheimer não causa flutuação nem alucinação precoce; demência vascular requer AVCs prévios; frontotemporal domina alterações comportamentais e linguagem; álcool costuma causar atrofia cerebelar e comprometimento executivo.

16) Mulher de 68 anos com Fibrilação Atrial de início há 48h, estável hemodinamicamente, CHA_2 DS_2 -VASc 3. Qual abordagem de exames e terapia?

a) Ecocardiograma transtorácico + anticoagular por 3 semanas antes da cardioversão;

b) Ecocardiograma transesofágico + anticoagular e cardioversão se ausência de trombos;
c) Holter 24h + iniciar amiodarona;
d) Tomografia de coronárias + aspirina.
Correta: b) Ecocardiograma transesofágico + anticoagular e cardioversão se ausência de trombos.
Justificativa: Para FA >24h de duração desconhecida, a diretriz SBC 2022 recomenda ecocardiograma transesofágico para excluir trombos antes da cardioversão, com anticoagulação adequada. Harrison (21ª ed, Cap. 274) reforça essa estratégia para minimizar risco embólico.

17) Paciente de 72 anos com ICFEr (Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida) classe IV (NYHA), FE 30%, em uso de carvedilol, enalapril e furosemida. Persiste com edema e dispneia em repouso. Qual adição terapêutica tem maior impacto na redução de mortalidade?
a) Espironolactona;
b) Digoxina;
c) Sacubitril/valsartana;
d) Hidralazina + nitrato.
Correta: c) Sacubitril/valsartana.
Justificativa: O estudo PARADIGM-HF mostrou superioridade do sacubitril/valsartana sobre IECA em reduzir mortalidade cardiovascular e hospitalizações em ICFEr classe II-IV. Diretriz SBC 2024 recomenda como substituto de IECA/ARA em pacientes ainda sintomáticos. Harrison (21ª ed, Cap. 277) posiciona como terapia de primeira linha.

18) Homem de 60 anos, sedentário, diabético em controle irregular procura atendimento devido a dor torácica atípica. Realizado ECG em repouso com resultado normal. Neste caso, das alternativas abaixo, qual exame provocativo não invasivo tem maior valor prognóstico e acurácia diagnóstica?
a) Teste ergométrico convencional;
b) Cintilografia de perfusão miocárdica com estresse farmacológico;
c) Ressonância cardíaca com estresse por dobutamina;
d) Angiotomografia computadorizada de coronárias.
Correta: b) Cintilografia de perfusão miocárdica com estresse farmacológico.
Justificativa: Para pacientes diabéticos com incapacidade para exercício, a cintilografia com estresse farmacológico (adenosina/dipiridamol) é recomendada pelas diretrizes SBC 2023 como primeira linha para diagnóstico e estratificação de risco. Harrison (21ª ed, Cap. 273) destaca sua acurácia superior ao teste ergométrico nesse grupo.

19) Paciente masculino de 55 anos em uso de losartana 100mg, anlodipino 10mg e hidroclorotiazida 25mg, com PA mantida >140/90 mmHg. A aderência às medicações foi confirmada pela esposa pois eles tomam as suas medicações juntos. Qual a próxima abordagem diagnóstica e terapêutica?
a) Adicionar espironolactona 25mg/dia;
b) Investigar hiperaldosteronismo primário e doença renal;
c) Substituir hidroclorotiazida por furosemida;
d) Encaminhar para denervação renal.
Correta: b) Investigar hiperaldosteronismo primário e doença renal.
Justificativa: Diretriz SBC 2020 recomenda investigação de causas secundárias antes de intensificar terapia em HÁ resistente. Hiperaldosteronismo primário é a causa endócrina mais comum. Harrison (21ª ed, Cap. 277) enfatiza a necessidade de excluir apneia do sono, estenose de artéria renal e outras causas.

20) Paciente homem, 57 anos, diabético, tabagista, com história de acidente vascular cerebral isquêmico há quatro anos e em uso contínuo de AAS, Atorvastatina, Metformina e Gliclazida, comparece em consulta de retorno na Unidade Básica de Saúde após seis meses. Neste momento, paciente apresentava PA de 132x87 mmHg. Foi orientado a manter as medicações, realizar as medidas não farmacológicas para pré-hipertensão arterial e retornar à consulta para nova avaliação. O paciente retorna dentro do prazo determinado e apresenta PA de 130x85 mmHg. Refere ter seguido adequadamente todas as orientações da última consulta. Considerando a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial de 2025, qual a conduta correta nesta consulta?
a) Iniciar tratamento medicamentoso em terapia dupla com Losartana e Anlodipino.
b) Manter orientações de medidas não medicamentosas, visto que paciente não apresenta PA ≥ 140x90 mmHg.
c) Iniciar tratamento medicamentoso em monoterapia com Losartana.

d) Solicitar exame de MAPA (Monitoração Ambulatorial da Pressão Arterial) e agendar retorno em seis meses.

Gabarito: C

- **C (correta)**: Paciente **alto risco cardiovascular** (diabetes + AVC prévio). Mesmo com PA < 140x90, a nova diretriz indica **início de tratamento farmacológico**. Pode-se iniciar **monoterapia**.
- **A**: Terapia dupla não é obrigatória com esses níveis pressóricos.
- **B**: Errada — ignora o **alto risco**, critério chave.
- **D**: MAPA pode ajudar, mas **não posterga tratamento em alto risco**.

21) Um homem de 50 anos com histórico de colite ulcerativa apresenta dor abdominal intensa, distensão e diarreia sanguinolenta profusa. No exame, parece toxemiado e a tomografia de abdome revela dilatação colônica > 6 cm. Qual é o próximo passo do tratamento?

a) apenas corticosteróides intravenosos e repouso intestinal
b) apenas terapia antibiótica com cobertura de amplo espectro
c) consulta cirúrgica de emergência para possível colectomia
d) avaliação endoscópica com biópsia

Gabarito: C

- **C (correta)**: Dilatação > 6 cm + toxemia = **megacólon tóxico** → **avaliação cirúrgica urgente**.
- **A**: Corticoide é inicial, mas aqui já há critério de gravidade.
- **B**: Antibiótico isolado é insuficiente.
- **D**: Colonoscopia é **contraindicada** (risco de perfuração).

22) Homem, 34 anos, em situação de rua, procura atendimento com queixa de tosse persistente, perda de peso, sudorese noturna e febre intermitente há cerca de 2 semanas. Diante deste caso, qual deve ser a conduta adotada?

a) Solicitar exame bacteriológico de escarro, juntamente com cultura e com teste de sensibilidade antimicrobiana, testagem para HIV, para hepatites virais e para sífilis.
b) Solicitar RX de tórax e, em caso de alteração, prescrever medicamentos (rifampicina / isoniazida /pirazinamida /etambutol) via tratamento diretamente observado.
c) Solicitar exame bacteriológico de escarro e, em caso positivo, encaminhar o paciente para serviço de referência em pneumologia para tratamento de tuberculose multirresistente.
d) Solicitar exame bacteriológico de escarro, testagem para HIV, para hepatites virais e para sífilis e, caso seja confirmada a presença de tuberculose, instituir tratamento diretamente observado.

Correta a alternativa A. Perfeito. Nas populações em estado de vulnerabilidade, para diagnóstico, é recomendada a solicitação não só do TRM-TB, mas também da baciloscopia e cultura com teste de sensibilidade.

Uma observação interessante: no Brasil, pela prevalência, é indicada pesquisa de tuberculose pulmonar em todos aqueles pacientes definidos como sintomáticos respiratórios. E quem são eles? Pelo Ministério da Saúde: é aquela pessoa que apresenta tosse por 3 semanas ou mais.

No entanto, nos estados de vulnerabilidade social, por se tratar de uma população com dificuldades relacionadas à percepção do tempo e muitas vezes também à percepção da tosse, o profissional de saúde deve considerar qualquer tempo de duração da tosse nas estratégias de busca ativa de sintomático respiratório.

Trata-se ainda de uma população de risco acrescido para HIV, hepatites e outras DSTs, portanto é importante que seja oferecida a testagem para HIV, hepatites virais e sífilis.

In**correta a alternativa B.** A radiografia de tórax é sim importante, no entanto precisamos também pesquisar diretamente a presença do bacilo.

Incorreta a alternativa C. Devemos solicitar, nestes casos, além da baciloscopia, o TRM e a cultura com teste de sensibilidade. Uma vez confirmado o diagnóstico, o tratamento pode ser feito inicialmente com o esquema padrão – RIPE. Terá de ser discutido, neste caso, se será realizada ou não a hospitalização para início do tratamento.

Incorreta a alternativa D. Devemos solicitar, nestes casos, além da baciloscopia, o TRM e a cultura com teste de sensibilidade. Uma vez confirmado o diagnóstico, o tratamento pode ser feito inicialmente com o esquema padrão – RIPE. Terá de ser discutido, neste caso, se será realizada ou não a hospitalização para início do tratamento.

23) Uma mulher de 47 anos de idade com índice de massa corporal (IMC) de 37 kg/m2 foi recentemente diagnosticada com diabetes mellitus tipo 2. Como parte da educação dessa paciente, você informa que a causa mais comum de morte em adultos com diabetes mellitus tipo 2 consiste em:

a) Doença arterial coronariana
b) Acidente vascular encefálico
c) Neuropatia
d) Insuficiência renal

Gabarito: A

- **A (correta)**: Principal causa = **doença cardiovascular**, especialmente coronariana.
- **B**: AVE é importante, mas não o principal.
- **C/D**: Complicações crônicas, porém menos prevalentes como causa de morte.

24) Considere que um paciente idoso, diabético em uso de metformina, iniciou quadro de hipertensão arterial sistêmica que não se resolveu com alteração alimentar, atividade física e com as outras orientações não farmacológicas. Das opções que dispomos para iniciar o tratamento da HAS deste paciente, assinale aquela de devemos **EVITAR**:

a) IECA/inibidores dos receptores AT1
b) Bloqueadores dos canais de cálcio
c) Betabloqueadores
d) Diurético

Gabarito: C

- **C (correta)**: Betabloqueadores não são primeira linha (mas não são proibidos — "pegadinha").
- **A/B/D**: São classes indicadas.

25) Mulher, 47 anos, diabética, encontra-se em tratamento quimioterápico para neoplasia de colo de útero. Procura atendimento médico por dor e edema de membro inferior esquerdo há 3 dias. Ao exame encontra-se normotensa, normocárdica, eupneica em ar ambiente com saturação de O2 normal, perfusão periférica preservada e pulsos distais palpáveis, com dor à palpação de panturrilha e coxa esquerdas. Ultrassom com doppler evidenciou trombo em veia ilíaca externa esquerda, e compressão extrínseca da mesma por linfonodos. Função renal normal. Qual a melhor conduta para o caso acima?

a) internação hospitalar para início de anticoagulação plena com bomba de heparina não fracionada
b) internação hospitalar para passar filtro de veia cava
c) anticoagulação plena com antagonista da vitamina K associado a antiagregação com Aspirina em regime ambulatorial
d) anticoagulação plena com heparina de baixo peso molecular ou anticoagulantes orais diretos em regime ambulatorial

Gabarito: D

- **D (correta)**: Anticoagulação com **HBPM ou DOAC ambulatorial**.
- **A**: Heparina EV não é necessária.
- **B**: Filtro só se contraindicação à anticoagulação.
- **C**: Varfarina + AAS → inadequado.

26) Homem de 62 anos apresentou quadro de febre de 39ºC acompanhada de exantema que entrou em remissão após 3 dias em repouso e com uso de analgésicos comuns. No início do quadro apresentava artralgia difusa, que permanece em mãos e pés após quatro semanas, com rigidez articular matinal e limitação de movimentos. Assinale a alternativa que corresponde à principal hipótese diagnóstica para o caso descrito:

a) Artrite gonocócica
b) Artrite reumatóide
c) Artrite reativa
d) Chikungunya

d) Chikungunya

 Raciocínio clínico

O quadro descrito é bastante característico de infecção pelo vírus **Chikungunya virus**:

 Fase aguda (inicial):

- Febre alta súbita (39 ºC)
- Exantema
- Artralgia intensa

 Evolução:

- Melhora da febre em poucos dias

- **Persistência de artralgia por semanas**
- Rigidez matinal e limitação funcional

 Esse padrão é clássico da **fase subaguda/crônica da Chikungunya**, que pode simular doenças reumatológicas.

❌Análise das alternativas erradas

a) Artrite gonocócica ❌

- Geralmente:
  - Poliartralgia migratória
  - Tenossinovite
  - Lesões cutâneas pustulosas
- Não cursa com exantema viral típico nem evolução prolongada como descrita

b) Artrite reumatoide ❌

- Doença crônica autoimune
- Início **insidioso**, não com febre alta + exantema
- Não costuma ter resolução parcial espontânea inicial

c) Artrite reativa ❌

- Ocorre após infecção (GI ou GU)
- Geralmente:
  - Oligoartrite assimétrica
  - Acometimento de grandes articulações
- Não tem quadro viral exantemático inicial

27) Mulher, 27 anos, com diagnóstico de hipertireoidismo primário em uso de metimazol há 6 meses. Refere melhora dos tremores e das palpitações. Queixa-se de odinofagia há 1 dia. Exame físico: bom estado geral, corada, hidratada. Pescoço: bócio difuso, sem nódulos delimitados, indolor, ausência de frêmito. Temp. axilar = 39oC; FC = 76 bpm; PA = 130 x 80 mmHg.
Qual exame deve ser solicitado?

a) hemograma
b) TGO e TGP
c) TSH e T4 livre
d) Proteína C Reativa

GABARITO a) hemograma

Raciocínio clínico

Paciente em uso de **Metimazol** há 6 meses, agora com:

- Febre alta (39 °C)
- Odinofagia aguda
- Esse é um **quadro clássico de alerta para agranulocitose induzida por tionamidas**.

Por que isso é importante?

A **agranulocitose** é um efeito adverso raro, porém grave do metimazol:

- Pode ocorrer em qualquer momento do tratamento
- Sintomas iniciais típicos:
  - Febre
  - Dor de garganta (odinofagia)

 Conduta imediata: **dosar leucócitos (hemograma)**

 Por que a alternativa A está correta?

- O **hemograma** permite:
  - Avaliar leucopenia
  - Confirmar **neutropenia/agranulocitose**

 Se confirmado:

- Suspender imediatamente o metimazol
- Iniciar suporte e, se necessário, antibióticos

❌Análise das alternativas erradas

b) TGO e TGP ❌

- Avaliam hepatotoxicidade (outro efeito colateral possível)
- Não explicam quadro de febre + odinofagia

c) TSH e T4 livre ❌

- Avaliam controle do hipertireoidismo
- Não têm relação com o quadro infeccioso agudo

d) Proteína C Reativa ❌

- Marcador inflamatório inespecífico

- Não identifica agranulocitose

28) Um homem de 22 anos, previamente saudável, procura o pronto-socorro com quadro de náuseas, vômitos e diarreia líquida sem sangue ou muco, associado a mialgia e fadiga intensa. Os sintomas começaram há dois dias, mas se intensificaram no último dia, com oito episódios de evacuação líquida nas últimas 24 horas, sem dificuldade em ingerir alimentos sólidos ou líquidos. Ao exame físico: paciente afebril, em regular estado geral, com sinais discretos de desidratação, extremidades bem perfundidas e quentes, abdome flácido, doloroso à palpação difusa, sem sinais de irritação peritoneal. Sinais vitais: PA 115 x 70 mmHg, FC 88 bpm. Com base nesse quadro clínico, qual a melhor conduta?
a) o paciente deve receber tratamento ambulatorial com hidratação oral, sintomático e orientação sobre sinais de alarme
b) o paciente necessita de internação hospitalar para hidratação venosa e antibioticoterapia empírica
c) o paciente deve ser internado para observação, pois há indicação de tomografia de abdome devido à suspeita de complicações
d) o paciente apresenta sinais de desidratação moderada, necessitando internação para reposição volêmica intensiva
Gabarito: A
- **A (correta)**: Hidratação oral + sintomáticos.
- **B/C/D**: Excesso de intervenção.

29) Um homem de 65 anos, procedente da zona rural, é encaminhado ao ambulatório de gastroenterologia de um hospital escola devido a quadro de disfagia progressiva desenvolvido há 1 ano. O quadro piorou há 2 meses. O paciente passou a apresentar vômitos frequentes com restos alimentares, sem sangue. Nesse período, ele perdeu cerca de 12% de seu peso corporal. A partir dessas informações, é correto afirmar que a investigação complementar inicial, considerando a etiologia mais provável desse quadro, deve incluir:
a) Esofagograma contrastado com bário, para avaliação da motilidade esofágica e identificação de áreas de estenose.
b) Manometria esofágica, para investigação de distúrbios motores como Acalasia.
c) Endoscopia digestiva alta com biópsia de possíveis lesões.
d) pHmetria esofágica de 24 horas, para avaliação de refluxo gastroesofágico
Gabarito: C
30) Mulher de 65 anos apresenta fadiga e palidez há 06 meses, além de artrite inflamatória de mãos e punhos. Tem antecedente de artrite reumatoide, em uso de metotrexato 15 mg/semana e ácido fólico 10 mg/semana. Nega outras comorbidades. Exames complementares evidenciaram: Hb 9,0 g/dL; VCM 75fL; reticulócitos 48.000/mm³; Ferro 35 mcg/dL (VR: 50-170 mcg/dl); capacidade total de ligação de ferro 189 mcg/dL (VR: 250-450 mcg/dl); ferritina 400 ng/mL (VR: 15-149 mcg/L) e índice de saturação de transferrina de 20,6% (VR: 20 a 40%). Ácido Fólico 10 ng/ml. Qual é a etiologia mais provável da anemia da paciente?
a) Anemia ferropriva
b) Anemia hemolítica auto-imune
c) Anemia por deficiência de acido fólico
d) Anemia de doença crônica
Gabarito: D
- **D (correta)**: Perfil típico de **anemia de doença crônica**:
  - Ferro ↓
  - TIBC ↓
  - Ferritina ↑
- **A**: Ferritina estaria baixa.
- **B/C**: Não compatíveis com dados.

31) Mulher, 30 anos, procurou atendimento com febre, mal-estar, náuseas, dor nas pernas e cefaleia holocraniana há três dias. Refere um episódio de vômito e 4 evacuações amolecidas hoje. Antecedentes epidemiológicos: casos semelhantes na vizinhança. Exame físico: FC= 78 bpm, PA= 110x70 mmHg; pele: discreto exantema macular em tórax, abdome e extremidades; prova do laço negativa. Hematócrito= 51%. A conduta é:
a) Liberar a paciente para casa com orientações gerais.
b) Coletar sorologia para dengue e liberar para casa com orientações gerais.

c) Hidratar, prescrever ciprofloxacina e liberar para casa com orientações gerais.
d) Coletar sorologia para dengue, hidratar, repetir hematócrito e reavaliar.

Gabarito: D

- **D (correta)**: Hemoconcentração (Ht 51%) → hidratar e reavaliar.
- **A**: Inadequado (há sinal de alarme).
- **B**: Sorologia não muda conduta inicial.
- **C**: Antibiótico sem indicação.

32) Homem, 37 anos, obeso, procura atendimento na UBS queixando-se de cefaléia unilateral, pulsátil de intensidade moderada associada a náuseas, foto e fonofobia. Relata que vem usando analgésico comum, mas os episódios acabam retornando e por isso, queria um medicamento que pudesse prevenir as crises. Antecedentes pessoais: refere constipação crônica com eliminação frequente de fezes em forma de "bolinhas" (fecalitos) e uso de supositório de glicerina para alívio. Refere epilepsia tendo apresentado três crises epilépticas no último ano. A medicação indicada para controle (prevenção) deste tipo de cefaléia neste paciente é:

a) propranolol
b) topiramato
c) carbamazepina
d) amitriptilina

Gabarito: B

- **B (correta)**: Topiramato → ideal (trata epilepsia + migrânea).
- **A**: Pode piorar fadiga.
- **C**: Não é profilático de migrânea.
- **D**: Piora constipação.

33) Homem de 28 anos de idade apresenta há 2 anos cefaleia uma vez por semana de forte intensidade, unilateral, pulsátil, com foto e fonofobia e acompanhada por náuseas. Nega fenômenos visuais ou somestésicos. Há 6 meses associou outro tipo de cefaleia quase diariamente, bilateral, de fraca a moderada intensidade, em aperto, sem outros sintomas. Faz uso diário de dipirona e cetoprofeno e nos momentos de exacerbação da dor usa sumatriptano. Quais são os diagnósticos desse paciente?

a) cefaléia tensional e enxaqueca com aura
b) enxaqueca com aura e cefaléia por abuso de medicações
c) enxaqueca sem aura e cefaléia por abuso de medicações
d) cefaléia tensional e enxaqueca sem aura

Gabarito: C

- **C (correta)**:
  - Enxaqueca sem aura
  - Cefaleia por abuso de medicação
- **Outras**: Combinações incorretas.

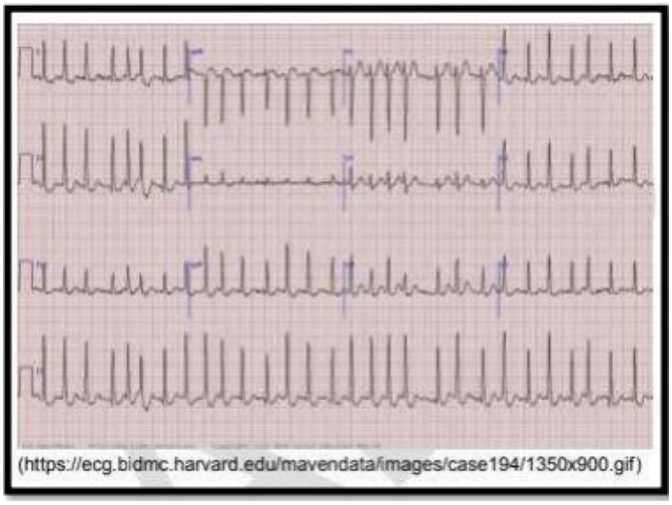
34) Uma mulher de 54 anos, sem antecedentes cardiovasculares, procura o pronto-socorro com queixa de palpitações há 18 horas acompanhadas de ortopneia e dispneia aos pequenos esforços. Apresenta pulso rápido e irregular, PA: 90 x 68 mmHg e estertores nas bases pulmonares. Antes de se tentar a reversão, elétrica ou medicamentosa da arritmia, é indicada a administração de:

a) Clopidrogel + AAS
b) Clopidrogel
c) AAS
d) Rivaroxabana

Gabarito: D

- **D (correta)**: Anticoagulação antes da reversão (se >48h ou tempo desconhecido).
- **A/B/C**: Antiagregantes não resolvem risco embólico.

35) Homem, 68 anos de idade, sem comorbidades, procura atendimento com queixa, há 1 hora, de palpitações. Nega episódios prévios. Há 3 meses apresenta perda ponderal não intencional, agitação psicomotora e insônia. Ao exame: pressão arterial = 110 x 60 mmHg, tireoide aumentada de tamanho, sem alterações ao exame cardiopulmonar. Foi realizado o eletrocardiograma reproduzido a seguir: Considerando o quadro clínico e a principal hipótese diagnóstica, qual deve ser a abordagem inicial para esse senhor, neste momento, no pronto-socorro?



a) cardioversão sincronizada
b) amiodarona 150 mg em 10 minutos
c) adenosina 6 mg em bolus
d) metoprolol 5 mg em 2 minutos

Gabarito: D

- **D (correta)**: Betabloqueador (controle de frequência).
- **A**: Cardioversão só se instável.
- **B/C**: Não são primeira linha.

36) Homem, 50 anos de idade, comparece para consulta de promoção da saúde. Não sabe se foi vacinado para hepatite B, porém sabe que na infância teve hepatite. A melhor combinação de resultados para indicar vacinação para hepatite B é:

a) Anti-HBc negativo, Anti-Hbs negativo
b) Anti-HBc negativo, AgHBs negativo
c) Anti-HBc positivo, AgHBs negativo
d) Anti-HBc positivo, Anti-HBs negativo

Gabarito: A

- **A (correta)**: Sem contato prévio e sem imunidade → vacinar.
- **B/C/D**: Indicam exposição prévia ou são redundantes.

37) Homem, 45 anos, agente da defesa civil, comparece à unidade básica de saúde para orientação após ter atuado no resgate de vítimas durante enchentes na sua cidade há dois dias. Relata que ficou exposto à água de enchente por várias horas, com contato até a cintura. Refere pequenos arranhões nas pernas, sem sinais de infecção local. Não apresenta sintomas no momento. Considerando o risco de leptospirose, qual deve ser a conduta mais adequada quanto à antibioticoterapia profilática?

a) A profilaxia de ser indicada, com prescrição de azitromicina 500 mg via oral, 3x/semana, enquanto ocorrer exposição.
b) Observar, sem indicação de profilaxia, já que ele não está sintomático.
c) Iniciar profilaxia com azitromicina apenas se surgirem sintomas nas próximas 72 hs.
d) A profilaxia deve ser indicada, com prescrição de doxiciclina 200 mg via oral, em dose única

Gabarito: D

- **D (correta)**: Doxiciclina dose única.
- **A**: Esquema incorreto.
- **B/C**: Perde oportunidade preventiva.

38) Mulher, 32 anos, está em investigação de trombocitopenia de surgimento recente, associada à elevação de escórias nitrogenadas. Hemograma: leucometria e hemoglobina em níveis normais. A visualização de hemácias fragmentadas (esquizócitos) na lâmina de sangue periférico sugere a hipótese diagnóstica, mais provável, de:

a) trombocitopenia pós-infecciosa
b) leucemia mielocítica aguda
c) púrpura trombocitopenica trombótica
d) trombocitopenia induzida por drogas

Gabarito: C

- **C (correta)**: Púrpura trombocitopênica trombótica.
- **Outras**: Não cursam com esquizócitos.

39) Homem, 32 anos, consultou com um médico devido à lesão eritematosa, exsudativa nas áreas inguinais e papulopústulas satélites. Após o diagnóstico de intertrigo por Candida, foi prescrito corticosteroide tópico combinado ao cetoconazol creme duas vezes ao dia. As lesões recidivaram com frequência, por isso, o paciente manteve a medicação prescrita por dois meses seguidos e notou o aparecimento de estrias e telangiectasias nas áreas inguinais. O que aconteceu?
a) O paciente não higienizava adequadamente região acometida, o que determinou aparecimento das outras lesões
b) O corticosteroide tópico utilizado a longo tempo na pele desencadeia estrias e as telangiectasias
c) O antifúngico cetoconazol em creme foi o responsável pelo aparecimento das estrias e as telangiectasias
d) O creme de combinação entre corticoide e antifúngico determinou o aparecimento de infecção bacteriana secundária, que causou o surgimento das estrias e as telangiectasias

b) O corticosteroide tópico utilizado a longo tempo na pele desencadeia estrias e as telangiectasias
 Raciocínio clínico
Paciente com **intertrigo candidiásico** tratado com:
- Antifúngico (cetoconazol)
- **Corticosteroide tópico**

Uso prolongado (**2 meses em área intertriginosa**) levou a:
- **Estrias**
- **Telangiectasias**

 Isso é efeito clássico de **corticosteroide tópico crônico**, especialmente em áreas de pele fina (como região inguinal).
 Mecanismo
O corticosteroide tópico causa:
- Atrofia da pele
- Redução de colágeno
- Fragilidade vascular

 Resultado:
- Estrias (atrofia dérmica)
- Telangiectasias (vasos superficiais visíveis)

❌Análise das alternativas erradas
a) Má higiene ❌
- Pode piorar candidíase, mas **não causa estrias nem telangiectasias**

c) Cetoconazol ❌
- Antifúngico tópico
- Não causa atrofia cutânea nem alterações vasculares

d) Infecção bacteriana secundária ❌
- Pode ocorrer em intertrigo
- Mas **não explica estrias e telangiectasias**

40) Homem, 68 anos, com história de DPOC grave (GOLD IV), ex-tabagista, apresenta-se ao pronto-socorro com quadro de dispneia progressiva, tosse com secreção purulenta há 2 dias, além de piora da saturação e sinais de desconforto respiratório. Ao exame: PA 130x85 mmHg, FC 105 bpm, FR 30 irpm, $SatO_2$ 82% (ar ambiente), ausculta com roncos e sibilos difusos. Gasometria: pH 7,28, $paCO_2$ 70 mmHg, HCO_3^- 32 mEq/L, PaO_2 55 mmHg. Ainda dentro desse caso clínico, CASO sejam indicados antimicrobianos, qual esquema antimicrobiano empírico mais apropriado?
a) Azitromicina isolada, pela sua cobertura contra germes atípicos, principais agentes na exacerbação do DPOC
b) Ceftriaxona associada à azitromicina, pela ampla cobertura de germes típicos e atípicos, especialmente em casos graves
c) Vancomicina associada a meropenem, considerando a gravidade do quadro e a necessidade de cobertura para Pseudomonas Aeroginosa
d) Amoxacilina, devido sua boa penetração pulmonar e perfil de segurança em idosos.

Gabarito: B

- **B (correta)**: Ceftriaxona + azitromicina → cobertura ampla.
- **A**: Cobertura insuficiente.
- **C**: Muito amplo (exagero).
- **D**: Cobertura limitada.